

31. MEP TRATTO GASTRO-INTESTINALE 1 : DELIMITAZIONE DELL'EMBRIONE

DURATA : 05:35

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video approfondisce l'instaurazione del tratto gastrointestinale e la delimitazione dell'embrione, concentrandosi sullo sviluppo dello stomaco, del duodeno e del colon. Vengono esplorati concetti chiave come la sincronicità dello sviluppo, la dinamica dei movimenti tridimensionali e l'importanza del diaframma per la delimitazione. Vengono dettagliate le relazioni tra i diversi organi, il peritoneo e le strutture associate, inclusi elementi come il mesogastrio e gli epiploon. Questo contenuto offre solide basi per qualsiasi pratica terapeutica, sottolineando l'importanza di una comprensione integrale dei processi embriologici in osteopatia.

POSIZIONAMENTO DEL TRATTO GASTROINTESTINALE E DELIMITAZIONE DELL'EMBRIONE

Studieremo il **posizionamento** del **tratto gastrointestinale**, della **cavità peritoneale** e del **peritoneo** nello sviluppo dello stomaco, del duodeno, dell'intestino e del colon.

Cominciamo col comprendere lo sviluppo dello stomaco in relazione al **fegato**, alla **milza** e al **pancreas**. È essenziale cogliere la fase iniziale, che chiamiamo la **delimitazione dell'embrione**. Abbiamo osservato l'integrazione del **celoma esterno** in un **celoma interno**. A questo stadio, possiamo vedere l'integrazione della cavità peritoneale, sia sul piano sagittale che trasversale.

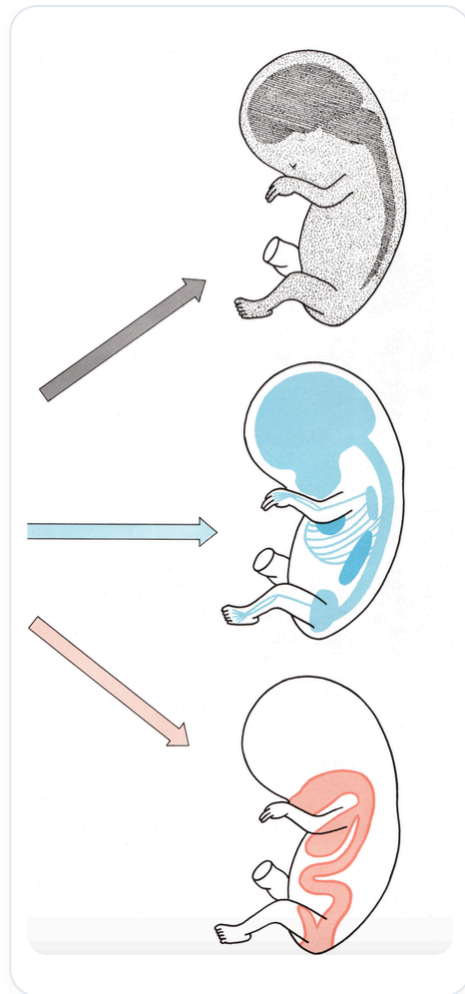


FIG. — Foglietti embrionali

Non dimenticate la **sincronicità** dello sviluppo. La crescita è il grande motore di questo processo, con la formazione del nostro corpo in un ordine primitivo. La crescita globale dell'embrione, il suo avvolgimento e il suo ritorno verso la linea mediana sono movimenti tridimensionali, e persino alla **quinta dimensione**. La quarta dimensione rappresenta il tempo, mentre la quinta dimensione si riferisce alla componente **energetica** ed **elettrica** che sottende l'intero sistema.

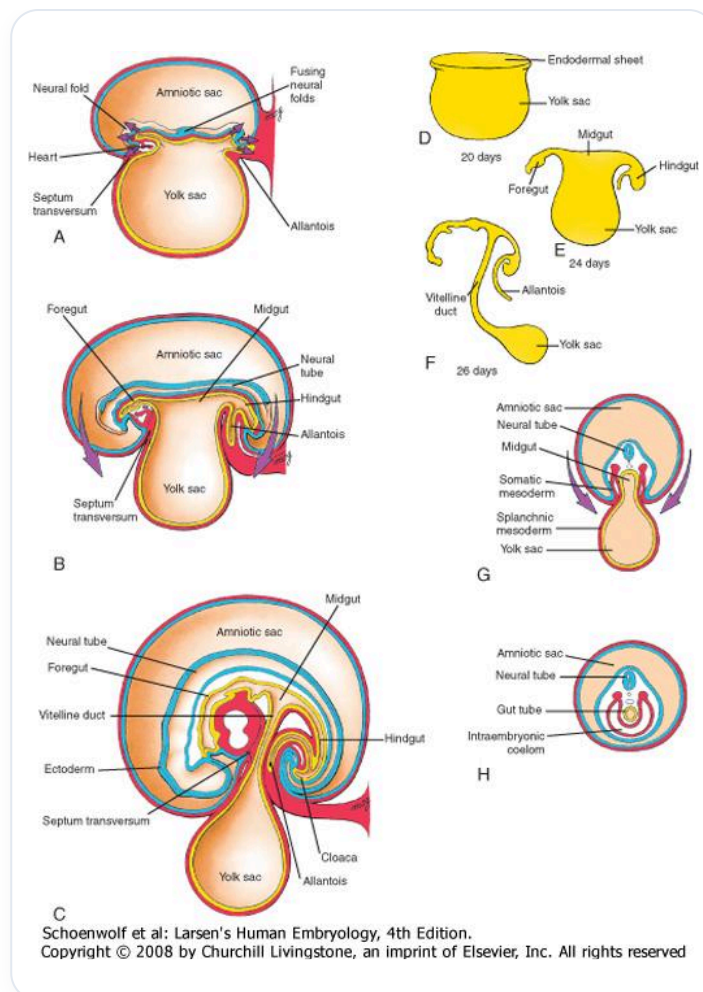


FIG. — Piegamento embrionale laterale

Questo movimento è sempre integrato nella fase di **ascensione dell'ectoderma** e di **discesa relativa dell'endoderma**, con una fase quasi a livello del cuore. L'ascensione dell'ectoderma e la discesa dell'endoderma, così come l'integrazione del cuore, stirano le **bozze** della muscolatura diaframmatica e dei futuri muscoli anteriori del collo. Per trattare e riorganizzare questo spazio, è cruciale comprendere che è necessario trattare e liberare il **diaframma**, poiché è esso che crea questa delimitazione globale.

L'ascensione del **tubo neurale**, lo sviluppo della cavità peritoneale e il posizionamento del cuore formano un movimento che si reintegra globalmente verso un punto di appoggio chiamato il **cordone ombelicale**. Questo cordone contiene la storia di questo sviluppo, di questa delimitazione e di questa riorganizzazione del peritoneo.

Questo processo si integra in movimenti di **rotazione specifici**, organizzati in senso orario e antiorario. Su un piano frontale, osserviamo un movimento di sviluppo globale **antiorario**, mentre su un piano trasversale, il movimento è **orario**. La cavità peritoneale inizia a organizzarsi e a delimitarsi, il che implica che si muoverà.

Il peritoneo circonda un organo, il che è chiamato un **peritoneo viscerale**. Quando un peritoneo collega un organo alla parte posteriore, si chiama un **meso**. Ad esempio, per lo stomaco, si chiama un **mesogastrio**, per il duodeno, un **mesoduodeno**, e per il colon, un **mesocolon**. A

seconda della localizzazione, può anche essere designato come una **fascia di Tholt**. Per l'intestino tenue, si parla di un **mesentere**.

Il peritoneo nella parte posteriore è chiamato **peritoneo parietale posteriore**, mentre nella parte laterale, è designato come **peritoneo parietale anteriore**. Se un peritoneo collega un organo a un altro organo, si chiama un **omento**. Ad esempio, il piccolo omento collega il fegato allo stomaco, ed esiste anche un omento che collega la milza allo stomaco.

Un omento o un meso è sempre una doppia lamina che contiene un vaso al centro. Nel movimento di sviluppo, si verificano pieghe e una riorganizzazione, permettendo all'omento, ad esempio il meso, di spostarsi lateralmente. Questo forma una **fascia di accollamento**, che può essere resecata dai chirurghi senza problemi, poiché non ci sono vasi. Un meso, d'altra parte, contiene sempre un vaso, mentre un legamento o una fascia non contiene necessariamente un vaso.

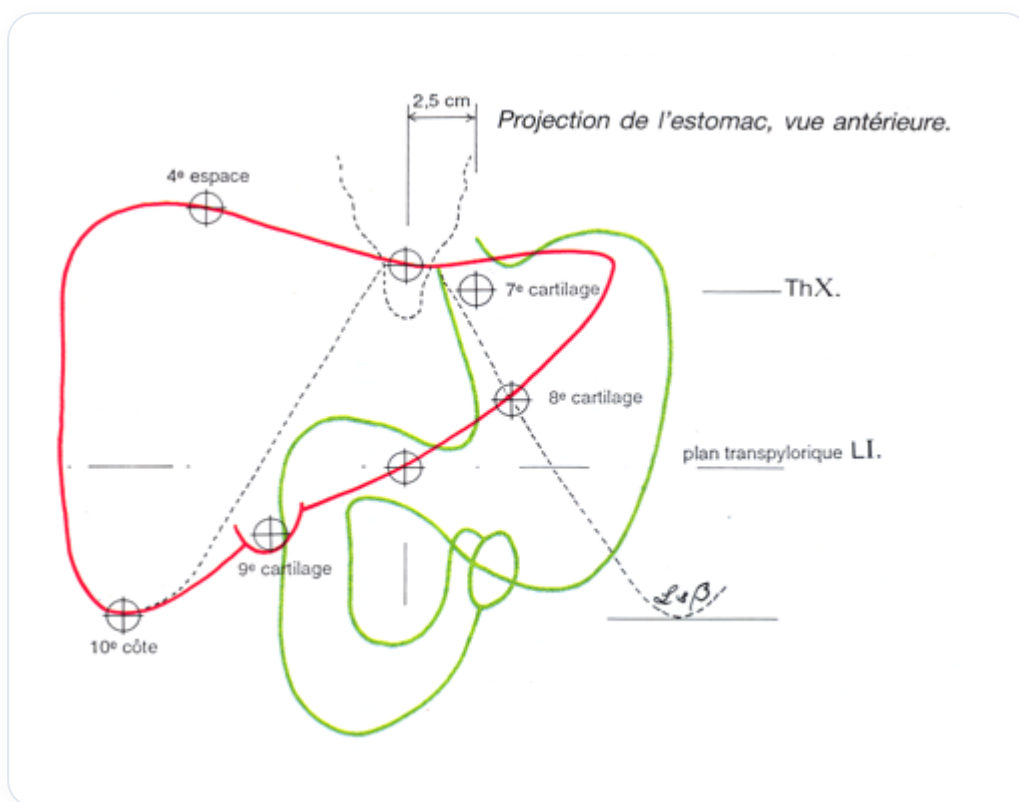


FIG. — *Proiezione stomaco anteriore*

A livello del peritoneo, abbiamo il **mesoderma**, la **somatopleura**, la **splanchnopleura**, così come il **mesogastrio** ventrale e dorsale. Abbiamo anche mesi, fasce, **omenti** (epiploici) e legamenti. Tutto ciò costituisce il peritoneo, organizzato nella cavità peritoneale.

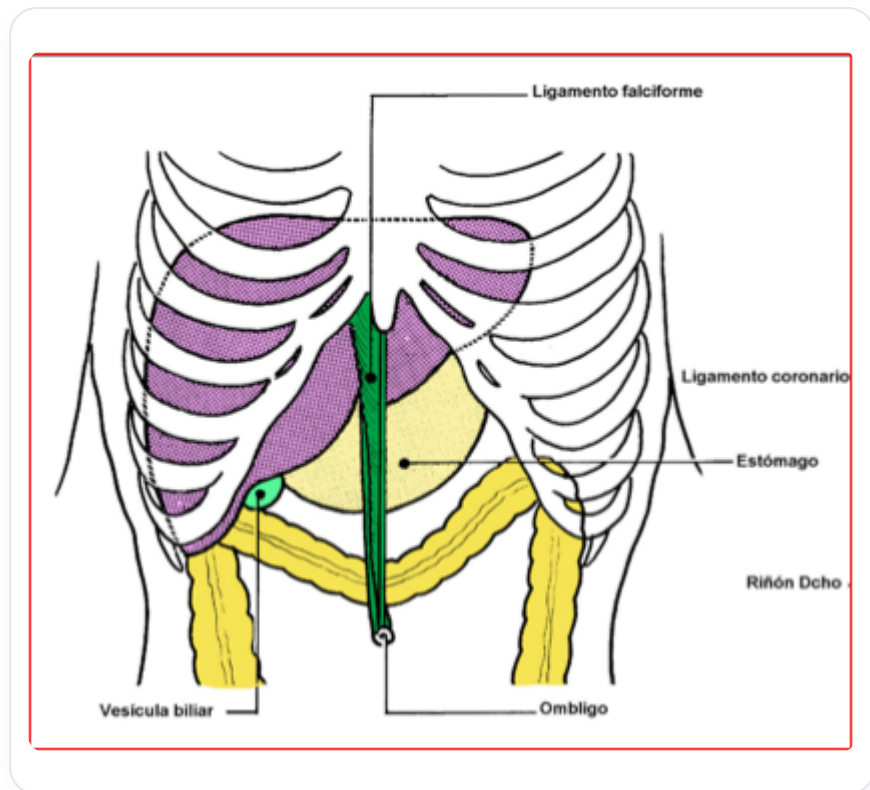


FIG. — *Anatomia addominale superiore*

L'intestino inizia a crescere, il fegato si sviluppa, lo stomaco vuole esprimersi e i polmoni spingono. Tutto ciò deve trovare il suo posto.

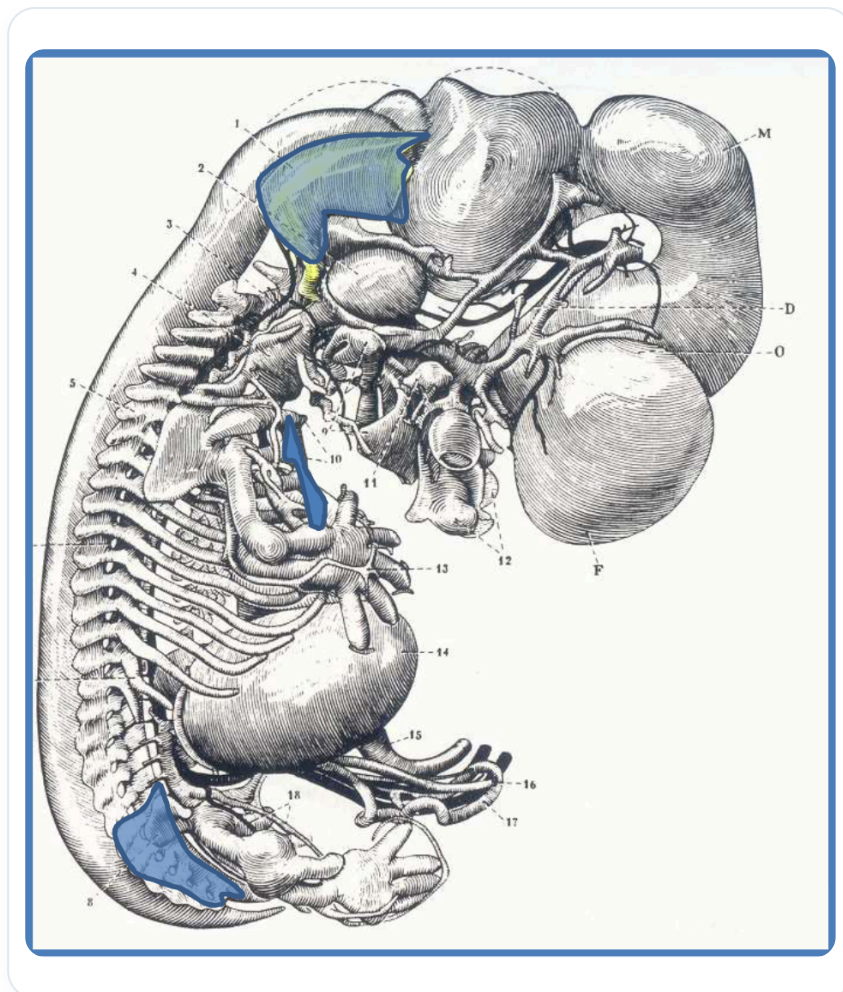
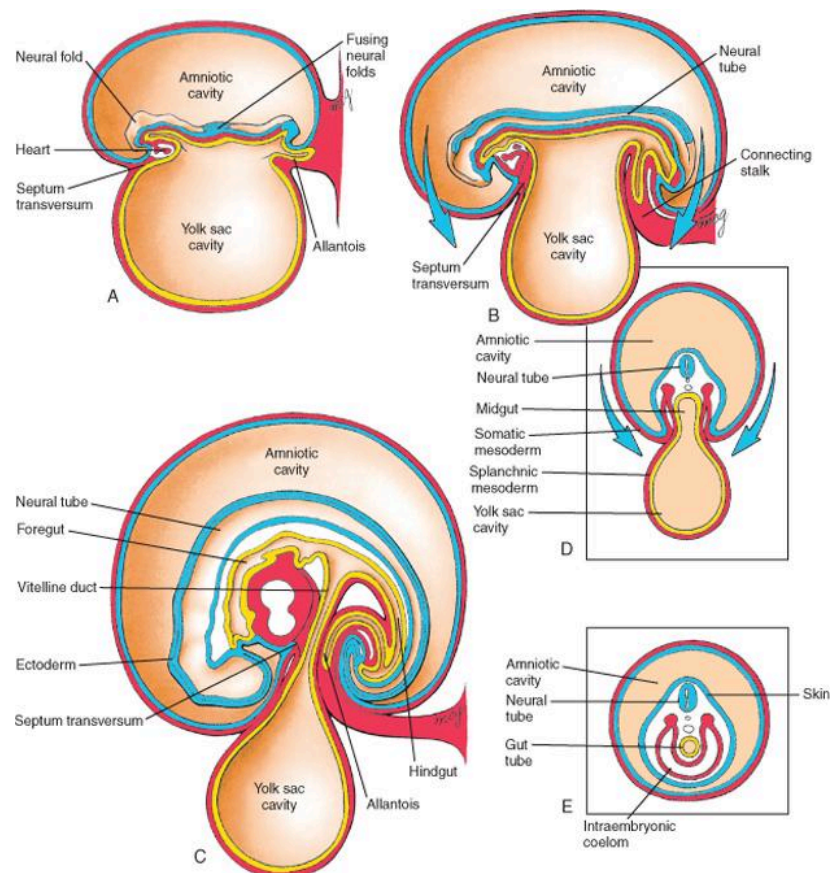


FIG. — Embrione umano, organi



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
 Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

FIG. — *Piegamento embrionale laterale/cranio-caudale*

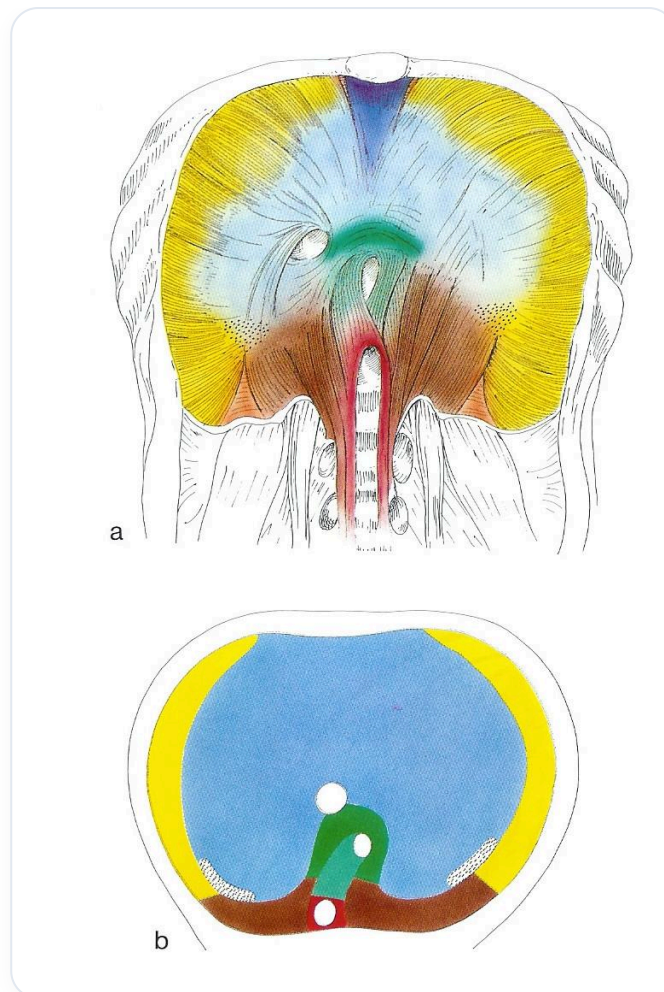


FIG. — Diaframma umano

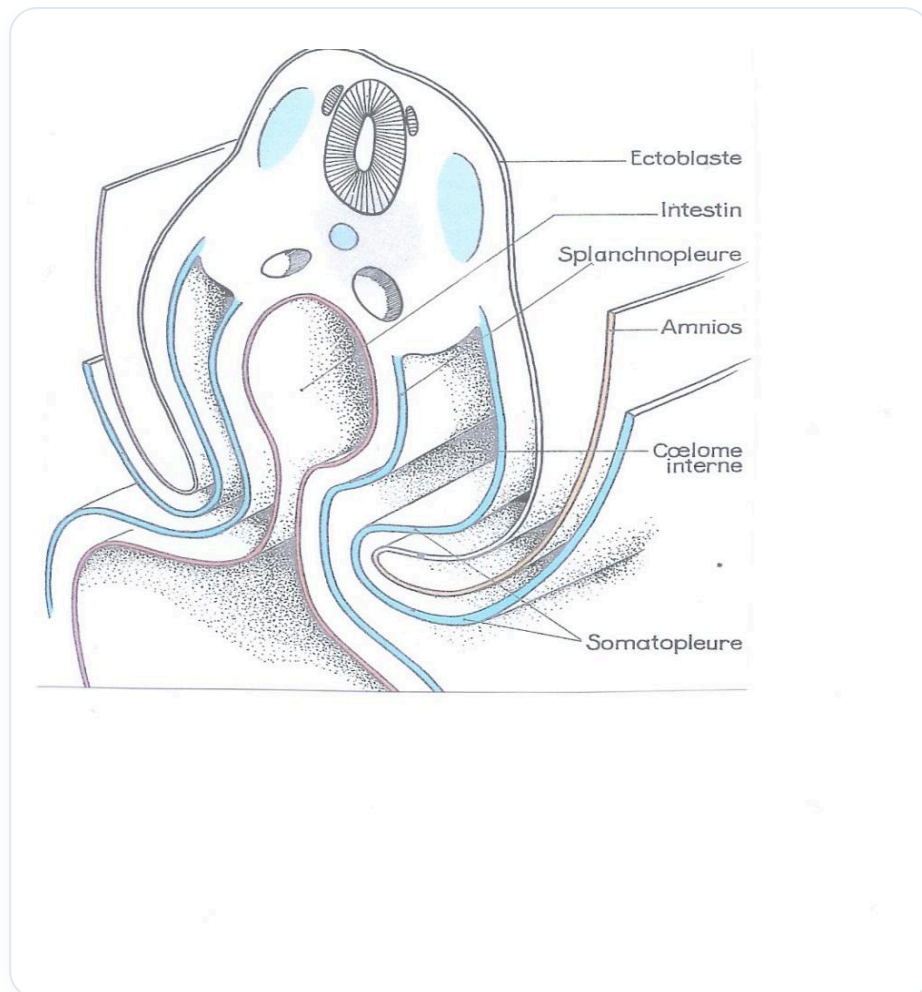


FIG. — *Piegamento embrionale laterale*